OdonTeck
CONSULTING GROUP

PROTOCOLO CLÍNICO · PERIODONCIA

Manejo de abscesos periodontales

Del diagnóstico diferencial al control: pasos de atención de urgencia, criterios para antibióticos y cuándo referir.

Equipo académico OdonTeck

Edición 1 · septiembre 2026

Qué es y por qué importa

El absceso periodontal es una acumulación localizada de pus dentro de la pared gingival de la bolsa periodontal, con destrucción tisular rápida. Es una de las pocas urgencias en periodoncia: su manejo oportuno alivia el dolor y limita la pérdida de inserción, y en pacientes con periodontitis avanzada puede ser la razón de perder el diente.

Clasificación (AAP/EFP 2017)

Contexto	Causas frecuentes
En paciente con periodontitis	Exacerbación aguda de una bolsa profunda sin tratar · Después del tratamiento: raspado incompleto que deja cálculo, cirugía periodontal, antibióticos sistémicos sin desbridamiento
En paciente sin periodontitis	Impactación de cuerpos extraños (cáscara de semilla, hilo dental, palillo) · Hábitos (morder objetos) · Factores ortodóncicos · Agrandamiento gingival · Alteraciones de la superficie radicular: fisuras, fracturas, perlas del esmalte, reabsorción externa

Diagnóstico

Hallazgo	Qué buscar
Síntomas	Dolor localizado, sensación de diente "alto", sabor desagradable
Signos	Tumefacción ovoide de la encía, enrojecimiento, supuración espontánea o al presionar, bolsa profunda en la zona, movilidad y extrusión
Vitalidad pulpar	Generalmente positiva (orienta contra origen endodóntico)
Radiografía	Pérdida ósea previa; puede ser normal en etapas iniciales
Estado general	Fiebre, malestar, linfadenopatía, trismus o celulitis indican compromiso sistémico

Diagnóstico diferencial

Entidad	Claves para distinguirla
Absceso periapical	Vitalidad pulpar negativa, caries o restauración profunda, lesión radiolúcida apical, dolor a la percusión vertical
Lesión endoperiodontal	Bolsa profunda que llega al ápice con pulpa necrótica; puede requerir ambos tratamientos
Absceso gingival	Limitado a encía marginal o papila en zona sin bolsa previa, a menudo por cuerpo extraño
Pericoronitis	Alrededor de un diente parcialmente erupcionado, típicamente tercer molar inferior
Diente fisurado o fractura radicular	Bolsa angosta y aislada, dolor a la masticación, antecedente de endodoncia o poste

Protocolo de atención

Paso 0 · Descarta urgencia médica
Fiebre alta, celulitis facial que se extiende, trismus, dificultad para tragar o respirar, o paciente inmunocomprometido descompensado: **referir de inmediato a servicio de urgencias o cirugía maxilofacial**. No retrases la referencia por intentar el drenaje.

1. **Historia y exploración**: sondaje cuidadoso, movilidad, vitalidad pulpar y radiografía periapical.
2. **Anestesia local** con técnica que evite inyectar dentro del área infectada.
3. **Drenaje a través de la bolsa**: introduce suavemente la cureta o la sonda para liberar el pus. Si el absceso está fluctuante y no drena por la bolsa, realiza una incisión en el punto más declive.
4. **Desbridamiento**: raspado y alisado de la zona, retirando cálculo y cuerpos extraños, con instrumentación cuidadosa para no dañar más la inserción.
5. **Irrigación** con solución salina o clorhexidina al 0.12%.
6. **Ajuste oclusal** si el diente está extruido y en trauma oclusal.
7. **Indicaciones y analgesia**: por ejemplo, ibuprofeno 400 mg cada 8 horas por 3 días si no hay contraindicación; enjuagues de clorhexidina 0.12% dos veces al día por 7–14 días; dieta blanda.
8. **Control a las 24–72 horas** para verificar remisión.
9. **Terapia periodontal definitiva** a los 7–14 días: tratamiento no quirúrgico completo, reevaluación y, si hace falta, cirugía o extracción.

¿Antibiótico sistémico?

El drenaje y el desbridamiento son el tratamiento. Los antibióticos sistémicos **no** sustituyen la intervención local y se reservan para:

- Afectación sistémica: fiebre, malestar general, linfadenopatía.
- Celulitis o diseminación de la infección.
- Pacientes inmunocomprometidos o con condiciones sistémicas de riesgo.

Situación	Esquema de referencia en adultos
Sin alergia a penicilina	Amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 5–7 días
Alergia a penicilina	Clindamicina 300 mg cada 8 horas por 5–7 días
Infección más extensa	Valorar amoxicilina con metronidazol 500 mg cada 8 horas, según criterio clínico y guías locales

Ajusta dosis y duración según peso, función renal, interacciones y guías vigentes de uso de antimicrobianos.

Criterios de pronóstico desfavorable

- Pérdida de inserción que alcanza el ápice o compromiso de furca avanzado.
- Movilidad grado III.
- Abscesos recurrentes en el mismo sitio.
- Fractura radicular vertical confirmada.

Indicaciones para el paciente

Tomar el medicamento como se indicó, mantener la higiene con cepillo suave en la zona, no presionar ni pinchar la encía, regresar antes de la cita si aumenta la inflamación, aparece fiebre o dificultad para abrir la boca o tragar.

Referencias

1. Herrera D, Retamal-Valdes B, Alonso B, Feres M. Acute periodontal lesions (periodontal abscesses and necrotizing periodontal diseases) and endo-periodontal lesions. J Clin Periodontol. 2018;45(Suppl 20):S78–S94.
2. Papapanou PN, Sanz M, et al. Periodontitis: consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop. J Clin Periodontol. 2018;45(Suppl 20):S162–S170.
3. Herrera D, Roldán S, Sanz M. The periodontal abscess: a review. J Clin Periodontol. 2000;27(6):377–386.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.